

CERVEJA E SAUDABILIDADE: COMO A PERCEPÇÃO DE SAUDABILIDADE DE UMA CERVEJA AFETA A INTENÇÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR

RESUMO

A ascensão da tendência conhecida como saudabilidade e bem estar (do inglês, *Health and Wellness*) está mudando a forma como os consumidores fazem suas escolhas alimentícias, destacando-se a procura por alimentos funcionais e produtos para dietas e controle do peso. Nesse cenário, a indústria de bebidas alcoólicas é vigorosamente afetada, em especial o mercado cervejeiro, uma vez que a cerveja, dentre todas as bebidas alcoólicas, é tida como uma antítese quando o assunto é saudabilidade. Mercados mais desenvolvidos estão endereçando tal tendência com cervejas menos calóricas e até mesmo, orgânicas, porém o mercado brasileiro está pouco desenvolvido no assunto. O presente estudo buscou compreender como a percepção de saudabilidade de uma cerveja influencia a intenção de compra (IC) do consumidor brasileiro bem como quais atributos tem maior apelo para tal percepção. Para tanto, foi realizada uma etapa qualitativa com grupos de foco e uma etapa quantitativa com uma *survey* (581 respondentes). A partir de uma modelagem de equações estruturais (MEE), observou-se que atributos de saudabilidade (*health claims*) como “baixa caloria”, “orgânica” e “*low-carb*” são os atributos de maior apelo a percepção de saudabilidade. Os resultados indicam que tal percepção tem influência significativa na intenção de compra do consumidor. Assim, o resultado do trabalho contribui para profissionais de marketing em busca por uma melhor compreensão da tendência de *Health and Wellness* aplicada ao setor de bebidas alcoólicas e de forma mais específica, indícios de como traduzir tal tendência para o consumidor de cerveja.

Palavras-chave: Cerveja. Saudabilidade. *Health and Wellness*.

ABSTRACT

The present study sought to understand how the perception of healthiness of a beer influences the Brazilian consumer's purchase intention as well as, taking a step back, which attributes most affect such perception.

The rise of a trend known as Health and Wellness is changing the way consumers make their food choices, highlighting the demand for functional foods and products for diets and weight control. In this scenario, the alcoholic beverage industry is strongly affected, especially the beer market, since beer, among all alcoholic beverages, is the antithesis of healthy. Developed beer markets are addressing this trend with less caloric and even organic beers, but the Brazilian market is underdeveloped on the subject. The present study sought to understand how the perception of healthiness of a beer influences the Brazilian consumer's purchase intention (PI) as well as which attributes have greater appeal for such perception. For that, a qualitative phase was carried out using focus groups and a quantitative phase using survey (581 respondents). From a structural equation modeling (SEM), it was observed that health claims such as “low-calorie”, “organic” and “low-carb” are the attributes of greatest appeal to the perception of healthiness and the results indicate that such perception has a significant influence in the consumer's purchase intention. Result of the study contributes to practitioners in search of a better understanding of the Health and Wellness trend applied to the alcoholic beverages sector and more specifically, indications of how to translate this trend to the beer consumer.

Keywords: Beer. Healthiness. Health and Wellness.

1. INTRODUÇÃO

Saudabilidade e bem estar está entre as cinco principais tendências para o setor alimentício no país em 2020, segundo estudo realizado pela Brasil Foods. As origens de tal movimento remetem a mudanças estruturais na sociedade, a exemplo do envelhecimento da população, urbanização e disponibilidade de renda e também a descobertas científicas recentes que associam determinadas dietas ao desenvolvimento de doenças. Nesse contexto, o mercado de *Health and Wellness* movimentou no mundo mais de quatro trilhões de dólares em 2018 e o segmento de alimentação saudável, nutrição e perda de peso foi responsável por 17% desse total. (GLOBAL WELLNESS INSTITUTE, 2018) A geração dos Millennials – jovens nascidos entre 1980 e 1998 e que a partir de 2030 representará 70% da força produtiva do mercado brasileiro, classificou saúde e bem estar como um dos elementos mais importantes de suas vidas, superado apenas pelo item família. (NERMOE, 2018) Além disso, 56% dos consumidores de comidas orgânicas são Millennials, contra 35% da geração X e apenas 14% dos Baby Boomers. Percebe-se então que os jovens estão cada vez mais preocupados com sua alimentação, buscam praticar mais exercícios físicos e reduzir aquilo que lhes parece prejudicial, ocasionando um aumento da demanda por alimentos saudáveis e funcionais, produtos para dietas e redução do peso e produtos orgânicos.

Nesse contexto, o mercado de bebidas alcoólicas é bastante afetado. Apesar de ter movimentado cerca de 590 milhões de dólares em 2018 ao redor do mundo, o consumo per capita está em queda. No Brasil, o consumo anual de cerveja por pessoa passou de 67 litros em 2012 para 60 litros em 2018, seguindo uma tendência de beber em menor quantidade, porém consumir líquidos de melhor qualidade (VENDEMIATTI, 2018). Estudos iniciais sobre percepção de saudabilidade (Wright et al., 2008) e demonstram que apesar de evidências de que tanto a cerveja quanto o vinho tinto são equivalentes em termos nutricionais, cerveja é percebida como menos saudável.

Nesse sentido, pesquisas no setor de alimentos mostram algumas estratégias utilizadas para que os consumidores percebam tais produtos como mais saudáveis. Uma dessas práticas é a utilização de *health claims* ou *nutritional claims* nas embalagens, frases informativas que funcionam como reforço de atributo, como *light* (leve), *low-carb* (baixo teor de carboidratos) ou ainda “natural” ou “orgânico”. Em relação às cervejas, segundo Williams (2005), aquelas que contêm algum *health claim* como, por exemplo “*light*”, são vistas como menos calórica e mais saudáveis. Entretanto, ainda são escassos os estudos que avaliam o impacto dessas informações adicionais na intenção de compra (IC) do consumidor.

Dessa forma, o presente trabalho tem como grande motivador duas tendências: a adoção crescente por hábitos alimentares saudáveis e o declínio no consumo per capita de cerveja. Em países como Estados Unidos e Canadá, locais onde essa tendência está em estágios mais avançados, as indústrias de bebidas alcoólicas estão buscando associar-se aos movimentos de *health and wellness*. No entanto, no Brasil, tal movimento ainda é pequeno. Assim, o presente estudo exploratório busca responder a seguinte pergunta: como a percepção de saudabilidade afeta a intenção de compra de cervejas mais saudáveis. O objetivo é propor uma análise que associa a percepção de saudabilidade à intenção de compra (IC) do consumidor e, de maneira mais específica, compreender quais fatores têm maior apelo a tal percepção para uma cerveja “melhor para você” no Brasil (ZEGLER, 2020).

Este artigo está estruturado em outras quatro seções: referencial teórico, no qual faz-se uma breve revisão sobre o fenômeno da saudabilidade, percepção de saudabilidade e por fim, uma análise do setor de bebidas alcoólicas no Brasil e nos Estados Unidos. Evoluindo, apresenta-se a metodologia utilizada, a análise e resultado do estudo e por fim encerra-se com as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Saudabilidade e Alimentação Saudável

O tema saudabilidade é bastante complexo uma vez que pode ser compreendido sob diversas perspectivas e é marcado por contextos históricos que remetem aos primórdios da humanidade. De maneira geral, podemos dizer que é um conceito transitório e caracterizado pela busca por melhor qualidade de vida, refletido por mudanças de hábitos alimentares e padrões de atividade física que, por sua vez, são sempre paralelos a mudanças maiores nas questões de saúde, mudanças demográficas e mudanças socioeconômicas (MISSAGIA; REZENDE, 2011). Nesse contexto de transições, segundo Barbosa et al. (2010), o envelhecimento da população e descobertas científicas que associam dietas a algumas doenças estão originando uma nova tendência conhecida como *Health and Wellness*, ou em português, saúde e bem estar. Com esse novo movimento destaca-se a busca por alimentos funcionais e produtos para dietas e controle do peso, bem como uma nova geração de produtos naturais, abrindo inúmeras oportunidades para indústria explorar tal realidade.

Falk et al. (2001) acreditam que as crenças pessoais relacionadas à alimentação variam em complexidade e de acordo com o contexto e é um fenômeno multideterminado. Na escolha por alimentos atuam forças psicológicas, sociais e culturais. Cinco valores representam uma série de considerações feitas ao escolher os alimentos: gosto, conveniência, custo, saúde e grupo de referência. No presente estudo, faz-se um retrato do valor “saúde”.

Saúde em particular é um valor que leva em consideração respostas imediatas como: desconforto digestivo, reações alérgicas, níveis de energia ou desempenho atlético, bem como considerações sobre consequência de longo prazo como: crescimento, controle de peso, controle de doenças ou prevenção. Num geral, os alimentos são classificados como “bom” ou “ruim” e a definição de alimentação saudável varia consideravelmente, incluindo equilíbrio geral, balanço de nutrientes, baixo teor de gordura, controle de peso, natural/orgânico, entre outros. (Falk et al., 2001).

Para Missagia et. al (2011), a adoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como a escolha por tais alimentos é marcado por fatores motivacionais como a preocupação com saúde, preocupação com aparência física e preocupação com bem estar - o segundo sendo o fator de maior peso motivacional-, e também fatores individuais, ligados à prática de atividade física e tempo disponível, fatores interpessoais, que podem ser caracterizados como a influência de grupos de referência e por fim, fatores ambientais, como a disponibilidade do produto, preço e marketing da indústria de alimentos. Ao final da revisão bibliográfica é mostrado como será feito o recorte do estudo tendo em vista a proposta dos pesquisadores.

2.2. Percepção de saudabilidade

No contexto de alimentação saudável, Paquette (2005) acredita que a percepção de saudabilidade dos alimentos pode ser considerada como um dos principais determinantes das escolhas alimentares. Estudos antigos mostram que os alimentos geralmente são caracterizados como saudáveis ou não saudáveis e diversos fatores influenciam tal categorização, como por exemplo a percepção de gordura, calorias e industrializados/naturais. Demonstra-se também que as percepções sobre saudabilidade podem enviesar as estimativas do conteúdo calórico da comida (Carels et. al, 2006). Escolhas alimentares “saudáveis” foram percebidas como tendo menos calorias do que a realidade, enquanto escolhas alimentares “não saudáveis” foram superestimadas em relação às calorias.

De acordo com Banterle et al. (2013), a informação no rótulo pode ser considerada como um dos atributos influenciadores da percepção de saudabilidade. O objetivo geral do painel frontal é facilitar a tomada de decisão dos consumidores. Esses demonstraram que utilizam as informações nutricionais dos rótulos para evitar certos ingredientes e para consultar a quantidade de componentes específicos, em especial gordura, calorias e açúcar (Roberto et al., 2012). Nesse sentido, segundo Williams (2005), consumidores tendem a perceber as reivindicações de saudabilidade como úteis e um produto que contém tal *claim* é tido como

mais saudável, ocasionando em maior inclinação para a compra.

Ainda no estudo de Williams, conclui-se que os consumidores preferem claims curtos e sucintos. No entanto, em contraste com tal descoberta, Grunert et al. (2005), reportou que há dois tipos de consumidores: aqueles que preferem mensagens curtas e aqueles que preferem informações mais detalhadas. Surge então uma terceira maneira para garantir a aceitação por ambos consumidores: dividir os claims na frente da embalagem de uma maneira mais sucinta e no verso, trazendo informações mais detalhadas. Ademais, ainda de acordo com Williams (2005), no caso de mensagens de saudabilidade, essas devem ser endossadas pelo governo ou alguma outra instituição para garantir sua credibilidade. Observa-se também que em categorias de produtos que não são diretamente associados a saudabilidade, o health claim mostra-se benéfico, com atitudes mais positivas para com o produto.

Por fim, não há resultados concretos sobre a presença de argumentos de saudabilidade e a posterior compra do produto. Enquanto alguns estudos reportam pouca correlação entre percepção de saudabilidade de um produto e sua real compra, outros mostram que *health claims* que se traduzem em percepções de saudabilidade tem grandes efeitos sobre a disposição para comprá-los. Entre outros atributos do produto que influenciam a compra, alguns estudos mostraram que a marca de um produto tem o maior impacto na compra de produtos com argumentos de saudabilidade.

2.2.1. Percepção dos consumidores em relação aos aspectos de saudabilidade de bebidas em geral

Wright et al. (2008) foi um dos precursores de pesquisas sobre a percepção de saudabilidade de bebidas alcoólicas pelos consumidores. Segundo seu estudo, tal percepção sobre o álcool é influenciada por inúmeros fatores que incluem: publicidade, anúncios dos serviços públicos, rotulagem dos produtos, reivindicações de saudabilidade e avisos sobre os danos do consumo. De acordo com sua pesquisa, consumidores percebem vinhos tintos como sendo o mais saudável entre seis tipos de bebidas. A cerveja tradicional apareceu em última posição, atrás do vinho tinto, vinho branco, cervejas rotuladas como “*Light*”, cervejas de coloração clara e cerveja de coloração escura, tanto para homens quanto para mulheres.

Além disso, entre 14 atributos que influenciam a compra de bebidas alcóolicas, o gosto é o que mais induz a escolha, seguido pela atividade e localização. Atributos de saudabilidade aparecem em último lugar. No entanto, é válido ressaltar que a pesquisa foi realizada em 2008. No trabalho em questão, os participantes da pesquisa disseram que bebem aquilo que gostam e não estão preocupados com a saudabilidade ou valores nutricionais de bebidas alcoólicas. Contudo, a percepção de saudabilidade mudou quando as bebidas foram servidas com informações nutricionais. Além disso, o autor notou que o conhecimento sobre o conteúdo nutricional de tais bebidas era limitado. Os indivíduos responderam corretamente em relação ao conteúdo alcoólico de vinho, cerveja, vodka e tequila, no entanto, poucos reconheceram que esses produtos possuem carboidratos. Ademais, mais pessoas associaram carboidratos à cerveja do que as outras bebidas.

Por fim, o autor comenta que a falta de informação nutricional no rótulo de tais bebidas pode ser o motivo de confusões e crenças equivocadas a respeito do real conteúdo nutricional de bebidas alcoólicas. Ainda, Wright et al. (2008) observou que as atitudes em relação ao produto seriam influenciadas por informações de saudabilidade.

Shemilt et al. (2017) explorou em sua revisão sistemática os efeitos da exposição de consumidores a certas rotulagens. Concluiu que quando esses eram expostos a cervejas rotuladas como “*light*”, acreditavam que as calorias e carboidratos de tal produto eram menores do que naqueles apontados como regular. No entanto a pesquisa foi inconclusiva quanto à intenção de consumo.

2.3. Análise do mercado

A fim de compreender melhor o mercado em questão, realizou-se uma análise

em dois locais: Brasil, país central do estudo e Estados Unidos.

2.3.1. Mercado Brasileiro

Em 2018, o mercado brasileiro de cerveja movimentou R\$ 107 bilhões de reais (1,6% do PIB do país). Dados da CervBrasil mostram que o setor é um dos maiores empregadores do país, sendo responsável pela geração de mais de 2,7 milhões de empregos direta e indiretamente, além de ser o terceiro maior produtor da bebida no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China. Menos fragmentado quando comparado ao mercado americano e outros Europeus, as cervejarias líderes incluem Ambev, com 60% do market share, Heineken e Grupo Petrópolis. (AFREBRAS, 2014). Além disso, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros, representando 90% do consumo de álcool. (REVISTA PESQUISA FAPESP, 2017).

Num geral, o mercado brasileiro possui menos opções que mercados mais desenvolvidos, como EUA e Europa. Uma pesquisa realizada pela instituto Mintel em 2020 mostrou que mais de um terço dos brasileiros adultos que já consumiram álcool disseram que provariam uma nova bebida alcoólica caso uma versão mais saudável estivesse disponível. O *health claim* “low”, “no” ou “reduzido” fora utilizado menos de 0,5% nas inovações das cervejas brasileiras entre novembro de 2013 e outubro de 2019. Ainda na pesquisa da Mintel, observou-se que mulheres adultas entre 18-24 e 45-54 anos provavelmente consumiram menos cerveja nos últimos seis meses. Assim, mais de um terço das mulheres consumidoras de bebidas alcoólica no país disseram que provariam mais bebidas não- alcoólicas ou coquetéis, comparados a um quarto dos homens que disseram estar interessados em bebidas não alcoólicas. Além disso, drinks não alcoólicos têm um potencial para desenvolver um público leal entre os jovens adultos dentro da idade permitida. Brasileiros entre 18-24 anos mostraram maior interesse em consumir drinks não alcoólico do que a média da população. (MINTEL, 2020)

Olhando para as prateleiras do mercado e buscando entender o que está disponível atualmente, vemos que em 2019, uma cervejaria artesanal conhecida como “NOI” desenvolveu uma cerveja low-carb com apenas 28 calorias por 100ml, 100% Puro Malte e com um teor Alcoólico de 4%. Ainda em 2019, a cervejaria Heineken trouxe ao país a “Heineken 0.0”, com o mote “Agora você pode”, apostando no crescimento do segmento de cervejas não alcoólicas. A Ambev por sua vez lançou no mesmo ano a Stella Artois Low-Gluten. No entanto o movimento ainda está em estágios iniciais.

2.3.2. Mercados Externos

Enquanto o mercado brasileiro está apenas começando a preocupar-se com as tendências de *Health and Wellness*, o interesse dos americanos nesse segmento não é novo e vem influenciando a indústria de comidas e bebidas há anos, conforme pesquisa realizada pela Partners Napier. Com os consumidores colocando maior importância no que comem e bebem e como isso os beneficia, a forma como consomem álcool também está sendo transformada.

Um estudo realizado pela Drinks Market Analysis em 2018, mostrou que gerações mais novas estão colocando menos importância no consumo de álcool e mais importância nas experiências. Além disso, um outro fator relacionado é que muitos consumidores acreditam que a *cannabis* é uma alternativa mais saudável do que a bebida alcoólica. Assim, conforme o consumo da maconha vem sendo legalizado em mais estados, a consideração entre álcool e cannabis torna-se mais relevante.

As grandes companhias de bebidas estão caminhando junto à tendência: a AB Inbev, dona da Budweiser, deseja que 20% da sua receita venha de produtos pouco ou não alcoólicos até 2025. A Heineken também lançou a Heineken 0.0 no mercado. Além das inúmeras outras opções já oferecidas, como a Michelob Ultra, Corona Light, Miller Lite, entre outras cervejas que possuem calorias reduzidas ou são menos alcólicas. Ainda assim, o segmento de

cervejas “*low-alcohol*” representou em 2018 0,5% do total da categoria, no entanto espera-se que o segmento de cervejas com menos álcool e/ou menos calóricas cresça 14% até 2022. (Drinks Market Analysis, 2018)

Ainda no estudo da Drinks Market Analysis, após o crescimento da cervejas artesanais as vendas de cervejas *lights* declinaram. No entanto, uma marca conseguiu manter seu crescimento: Michelob Ultra, que possui em seu portfólio a Michelob Ultra – Superior Light Beer e a Michelob Ultra Pure Gold, que contém em seu rótulo o argumento “orgânica”. Nota-se que a comunicação da marca num geral é bastante peculiar, sempre fazendo conexões entre a prática de exercícios físicos e o consumo de álcool, evidenciando um desejo dos consumidores de serem saudáveis e ainda poderem beber suas cervejas.

2.4. Considerações

Até o momento, os autores não encontraram nas bases EBSCO, ScienceDirect, Scopus, WoS, ProQuest, GoogleDocs, Periódicos-Capes e Spell modelos que associem as motivações do consumo de bebidas alcoólicas ao consumo de cervejas mais saudáveis. Assim, o presente estudo faz uma adaptação ao modelo apresentado por Missagia e Rezende (2011), estudando dentro dos fatores ambientais que influenciam a adoção de hábitos alimentares saudáveis, a percepção de saudabilidade da cerveja e utiliza como base principal a pesquisa realizada por Wright et. al (2008), que traz indícios sobre a percepção de saudabilidade de bebidas alcoólicas. Dessa forma, tem-se a construção da hipótese analisada no trabalho em questão:

H1: Percepção de saudabilidade tem influência significativa na intenção de compra de cervejas mais saudáveis.

O Quadro 1 resume os principais construtos utilizados na pesquisa.

CONSTRUT O ESCRITO	AUTORES	RESUMO	RELAÇÃO COM QUESTÃO DE PESQUISA
Alimentação Saudável	Missagia e Rezende, (2011) Paquette (2005) Falk et al (2001)	A definição de alimentação saudável pelos consumidores é complexa e multifacetada e considera-se quatro grandes influências: fatores motivacionais (preocupação com saúde, bem estar e aparência física), fatores interpessoais, fatores individuais e fatores ambientais.	Comportamento do consumidor em relação a alimentação saudável.
Percepção de saudabilidade	Paquette (2005), Verbeke et al. (2007), Carels et al. (2006).	A percepção de saudabilidade dos alimentos tem influência na escolha por alimentos. O painel frontal dos produtos é um dos principais influenciadores da percepção de saudabilidade	Influências sobre a percepção de saudabilidade de alimentos
Percepção de saudabilidade de bebidas alcoólicas	Wright et al. (2008) Shemilt et al (2017) William, P (2005)	Cerveja é vista como bebida alcoólica menos saudável. Sexo masculino tende a classificar bebidas alcoólicas como mais saudáveis que as mulheres. Por fim, a falta de informação nutricional é fonte de confusão e má interpretação sobre o conteúdo das bebidas alcoólicas.	Como os consumidores enxergam a saudabilidade de bebidas alcoólicas em geral

Quadro 1 – Constructos utilizados no estudo. Fonte: elaborado pelos autores.

3. METODOLOGIA

Em relação a metodologia utilizada, optou-se por separar a pesquisa em duas etapas: uma etapa exploratória, com dois grupos de foco, bem como uma etapa descritiva, que predomina o trabalho. Importante frisar que o presente estudo é de natureza objetiva,

quantitativa e imparcial, ou seja, livre de valores e tem voz impessoal bem como formal, contudo, embora sua essência seja quantitativa, fez-se necessário para o documento a realização de grupos focais, uma vez que o tema proposto envolve o comportamento do consumidor, repleto de subjetivismos.

3.1. Pesquisa Qualitativa

Para a coleta de dados da pesquisa qualitativa, 22 pessoas estiveram envolvidas. Dessas, quatorze estavam no primeiro grupo de foco e oito delas no segundo grupo, todos eles eram bebedores de álcool. A entrevista foi realizada via Zoom, plataforma de videoconferência. Seguindo um roteiro semiestruturado, os indivíduos debateram sobre suas percepções de saúde num geral e posteriormente, de forma sutil, sobre suas percepções de saudabilidade nas bebidas alcóolicas e mais especificamente, na cerveja. A análise foi realizada levando em consideração a frequência dos dados mais reiterados pelos participantes e os principais comentários sobre.

3.2. Pesquisa Quantitativa

O instrumento de coleta da pesquisa quantitativa foi um *survey online* com diversas perguntas a respeito da percepção de saudabilidade e com as escalas adaptadas (ver Tabela 1). Inicialmente foi realizado um pré-teste com 12 respondentes. Posteriormente, utilizando uma amostra de conveniência de grupos de consumidores em mídias sociais interessados em cerveja, obteve-se uma amostra de 581 consumidores. Após análise de adequação dos dados (outliers, normalidade, homocedasticidade, entre outros) foi realizada através do método de Modelagem de Equações Estruturais (SEM) por PLS, utilizando-se o SmartPLS 3.2.

3.2.1. Escala e elaboração do questionário

Para elaboração do questionário quantitativo, a fim de entender quais indicadores melhor refletem a percepção de saudabilidade de uma cerveja e iniciar a elaboração das questões, utilizou-se os grupos focais, com os insights mencionados posteriormente) e a revisão de literatura, que traz argumentos de saudabilidade utilizados em outras indústrias e práticas já realizadas em outros países. Abaixo apresenta-se os indicadores de saudabilidade utilizados e sua fonte.

Tabela 1 - Variáveis Observáveis para percepção de Saudabilidade e suas Origens

Segmento	Item	Origem
Health Claims	Low-Calories	Wright et al (2008)
	Low-Carb	Wright et al (2008)
	Orgânico	Michelob Ultra (EUA e Canadá)
	Light	Wright et al (2008)
	Gluten-Free	Stella Artois
Embalagem	Long Neck Transparente	Fase qualitativa da pesquisa
Propaganda	Influenciadores	Fase qualitativa da pesquisa
	Comerciais associados a esportes	Michelob Ultra (EUA e Canadá)
Custo-Benefício	Preço	Fase qualitativa da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dessa forma, chegou-se a dois construtos em relação a cerveja: percepção de saudabilidade, variável latente exógena e indicada pelos argumentos acima e intenção de compra, variável latente endógena. O questionário final, com 25 questões, passou pelo pré-teste, recebendo 12 respostas. Após críticas de especialistas e opiniões de demais

respondentes, o levantamento foi corrigido e seguiu para coleta final com 21 questões. A escala de concordância que caracterizou toda a pesquisa foi a Likert de 7 pontos (1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente). O questionário foi realizado online a partir da plataforma “*question pro*” e foi enviado através de redes sociais como: *Whatsapp*, *Facebook* e *Instagram*. Como algumas questões continham termos em inglês, os respondentes tiveram acesso a uma tradução com a explicação antes de responderem.

4. ANÁLISE DE DADOS

4.1. Análise de dados e resultados da pesquisa qualitativa

A etapa qualitativa tinha como principais objetivos explorar a relação dos participantes com questões de saúde e posteriormente a percepção dos mesmos sobre a saudabilidade da cerveja, a fim de gerar insights e outras hipóteses que pudessem ser levadas para a pesquisa quantitativa. O roteiro foi semiestruturado com base nas perguntas “O que é ser saudável?” e “O que seria uma cerveja saudável?”. Com essas primeiras indagações em mente, o tema foi sendo desenvolvido. A análise baseou-se em ouvir novamente o relato dos indivíduos e compreender as expressões mais utilizadas, classificando-as em três categorias (1) Ser saudável, (2) Álcool e Dieta e (3) Cerveja e Atributos.

Quanto a ser saudável, observa-se que o conceito está intimamente ligado a ideia de equilíbrio, unindo a prática de exercícios físicos com uma alimentação equilibrada. Os participantes dos dois grupos focais disseram que analisam se um produto é saudável ou não em grande parte através das informações nutricionais no rótulo do produto e que quando possível, optam por alimentos orgânicos pois acreditam que é melhor para sua saúde. Apesar de acreditarem no “equilíbrio” e no hábito de consumir álcool como parte desse balanço, a imagem de uma cerveja ou uma bebida alcoólica por si própria saudável parecia muito distante para os consumidores, causando bastante estranhamento e também curiosidade. Importante notar que a associação de álcool e saudabilidade veio apenas numa segunda instância, quando foi necessário refletir sobre o que seria o tal equilíbrio.

Na segunda categoria, “álcool e dieta”, comentou-se o fato da cerveja ser entre as bebidas alcoólicas, a maior inimiga das dietas, no entanto apenas um dos 22 entrevistados havia procurado as informações nutricionais sobre o produto e nenhum sabia quantas calorias estava ingerindo em uma embalagem de 330 ml da bebida. Disseram também que quando estão consumindo bebidas alcoólicas não se sentem “mal” no momento, como se a decisão de sair da dieta já tivesse sido feita previamente e que agora apenas iriam “curtir” a experiência. Ademais, quando questionados sobre os mitos que já ouviram sobre bebidas alcoólicas num geral, a única bebida lembrada fora a cerveja, sendo os principais deles “cerveja dá barriga” e “tomar uma cerveja equivale a comer um pão”. O moderador então questionou sobre os mitos a respeito de outras bebidas alcoólicas e não obteve respostas. Além disso, muito comentou-se sobre o fato de cerveja estufar, fazendo com que se sintam mal, assim, os participantes disseram que uma cerveja mais “leve”, que reduza a sensação de estufamento pode ser o caminho para uma cerveja percebida como mais saudável.

Por fim, em relação à última categoria, “cerveja e seus atributos”, a ideia era entender de forma direta quais atributos são mais relevantes para percepção de saudabilidade. Algumas divergências entre os dois grupos foram notadas. O primeiro grupo classificou “orgânica” como o *health claim* que mais lhes interessa, seguido por *low-calories* e *low-carbs*. Além disso, para o grupo, uma cerveja categorizada como “*light*” soou como puro oportunismo e enganação por parte das cervejarias. Já o segundo grupo caracterizou “*low-calories*” e “*low-cab*” como os principais atributos que chamam atenção quando pensam em uma cerveja mais saudável. Ainda, levantou-se a hipótese de que cervejas em embalagens de vidro transparente

são “cervejas mais leves” e consequentemente, mais saudáveis.

Ao final, três comerciais de cervejas com atributos de saudabilidade foram mostrados aos participantes. O primeiro é de propriedade da Corona Light, o segundo da marca Heineken Light e o último da marca Michelob Ultra. Esse último sendo o que causou maior estranhamento ao associar a prática de exercícios físicos com beber cerveja. No entanto, posteriormente os participantes disseram achar inédito que uma marca de cerveja se associe a esse público e tal conexão foi bem recebida.

Em suma, na parte qualitativa observou-se que uma embalagem de cerveja transparente causa no grupo uma ideia de saudabilidade. Da mesma forma, argumentos nutricionais como *low-calorie*, *low carb* e orgânico tiveram impacto positivo no grupo, enquanto o atributo light causava certo estranhamento negativo. Com tais ideias em mente, seguiu-se para a próxima etapa.

4.2. Análise de dados e resultados da pesquisa quantitativa

4.2.1. Análise exploratória do banco de dados e caracterização da amostra

Para melhor entender as respostas obtidas, realizou-se uma análise exploratória do banco de dados, buscando-se as principais características, valores ausentes (*missing values*) e a existência de outliers. Foram obtidos 581 elementos e nenhum desses foram excluídos. A idade média dos respondentes foi de 31 anos e nenhum respondente menor de 18 anos poderia responder a pesquisa, sendo este direcionado ao final da mesma. Ao observar o gênero dos respondentes, tem-se que 64% identificaram-se como mulheres e 36% como homens. A questão a respeito da renda da família dos entrevistados baseou-se no critério do IBGE e chama a atenção dois percentuais majoritários: 38,5% com renda familiar acima de R\$ 15.585,00 (+15 salários mínimos) e 34% dos respondentes com renda entre R\$ 5.195,00 e R\$ 15.585,00. Por fim, em relação ao nível de escolaridade observa-se que 45% possuem superior completo e 205 (35%) possui superior incompleto.

Ademais, todos os respondentes eram bebedores de bebidas alcoólicas. Analisando tal relação, observa-se que 27% dos respondentes bebem bebidas alcoólicas frequentemente e 88% são bebedores de cerveja. Optou-se por permitir que não bebedores de cerveja respondessem as demais perguntas uma vez que a ideia é entender a percepção de saudabilidade e se possivelmente uma percepção positiva levaria a uma maior intenção de compra inclusive por não bebedores. Além disso, 55,7% dos respondentes são praticantes de atividades físicas frequentemente a diariamente.

4.2.2. Estatística descritiva das variáveis

A fim de melhor visualizar os dados, foi construída a tabela abaixo, que relaciona os dois construtos e analisa algumas estatísticas descritivas como mínimo, máximo, média, desvio padrão e por fim, mediana.

Ao analisar a percepção de saudabilidade, observa-se que as médias dos dados se concentram nos valores médios da escala. As variáveis P1 e COM1 ficam consideravelmente abaixo da média da escala, mostrando um posicionamento negativo. Em relação ao construto intenção de compra, o desvio padrão está abaixo de 1,75 e os dados estão acima da média da escala, sendo bastante significativo, assim como a mediana do IC1 é bem próxima ao valor máximo da escala.

Tabela 2 - Estatísticas descritivas das variáveis dos construtos

CONSTRUTOS	n	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Mediana
Percepção de Saudabilidade						
HC1: Eu acredito que uma cerveja que contenha em seu rótulo “low-calories” seja mais saudável	581	1	7	4,96	1,675	5
HC2: Eu acredito que uma cerveja que contenha em seu rótulo “low-carb” seja mais saudável	581	1	7	4,98	1,605	5
HC3: Eu acredito que uma cerveja que contenha em seu rótulo “orgânica” seja mais saudável	581	1	7	5,02	1,696	5
HC4: Eu acredito que uma cerveja que contenha em seu rótulo “light” seja mais saudável	581	1	7	4,46	1,686	5
HC5: Eu acredito que uma cerveja que contenha em seu rótulo “gluten-free” seja mais saudável	581	1	7	4,25	1,922	4
EMB1: Uma cerveja em embalagem de vidro transparente me parece ser mais leve que outras	581	1	7	3,90	1,981	4
EMB2: Uma cerveja em embalagem de vidro transparente me parece ser mais saudável que outras	581	1	7	3,15	1,757	3
P1: Eu acredito que uma cerveja mais cara é uma cerveja mais saudável	581	1	7	2,99	1,740	3
COM1: Um comercial de cerveja no qual as pessoas estão realizando exercícios físicos demonstra que tal cerveja é mais saudável que as outras	581	1	7	2,95	1,796	3
COM2: Uma cerveja tomada por um/uma influenciador(a) fitness me parece ser mais saudável que outras	581	1	7	3,32	1,951	3
COM2: Uma cerveja indicada por um/uma influenciador(a) fitness me parece ser mais saudável que outras	581	1	7	3,11	1,829	3
Intenção de Compra						
IC1: Eu gostaria de comprar/consumir uma cerveja mais saudável que as outras	581	1	7	5,42	1,631	6
IC2: É provável que eu compre/consuma uma cerveja mais saudável que as outras	581	1	7	5,14	1,682	5

Observações: (1) HC: health claim. (2) EMB: embalagem (3) P: preço (4) COM: Comunicação. (5) IC: Intenção de Compra/Consumo (6) Mínimo: menor valor encontrado na escala (7) Máximo: maior valor encontrado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2.3. Método de equações estruturais: Análise do modelo de mensuração e modelo estrutural

Feito a parte exploratória dos dados, iniciou-se a análise mais profunda do mesmo a partir do Método de Equações Estruturais (SEM) por PLS, uma vez que tal método tem como objetivo explicar as relações entre múltiplas variáveis. Optou-se para o presente trabalho a utilização do PLS-SEM. Para tanto, foi utilizado o programa SmartPLS 3.2. Para o MEE, é importante dividir o modelo em duas partes. A primeira delas, conhecida como modelo de mensuração ou *Outer Model*, busca verificar se os itens de cada construto de fato representam com precisão o conceito desejado. A segunda parte, conhecida como modelo estrutural ou *Inner Model*, irá definir a associação entre as variáveis latentes.

Ao rodar o software com todas as variáveis propostas inicialmente, obteve-se o modelo da Figura 1. Seguindo o método proposto, avaliamos agora o modelo de mensuração a fim de garantir que as variáveis observáveis, criadas para mensurar as variáveis latentes, são significantes para o conceito desejado. Os primeiros aspectos a serem analisados são as

Validades Convergentes, obtidas pela Variâncias Médias Extraídas (*Average Variance Extracted* - AVE). Para tanto, foi utilizado o critério de Fornell e Larcker (HENSELER et al., 2009) e segundo a literatura, a AVE relaciona o quanto as variáveis explicam seus construtos.

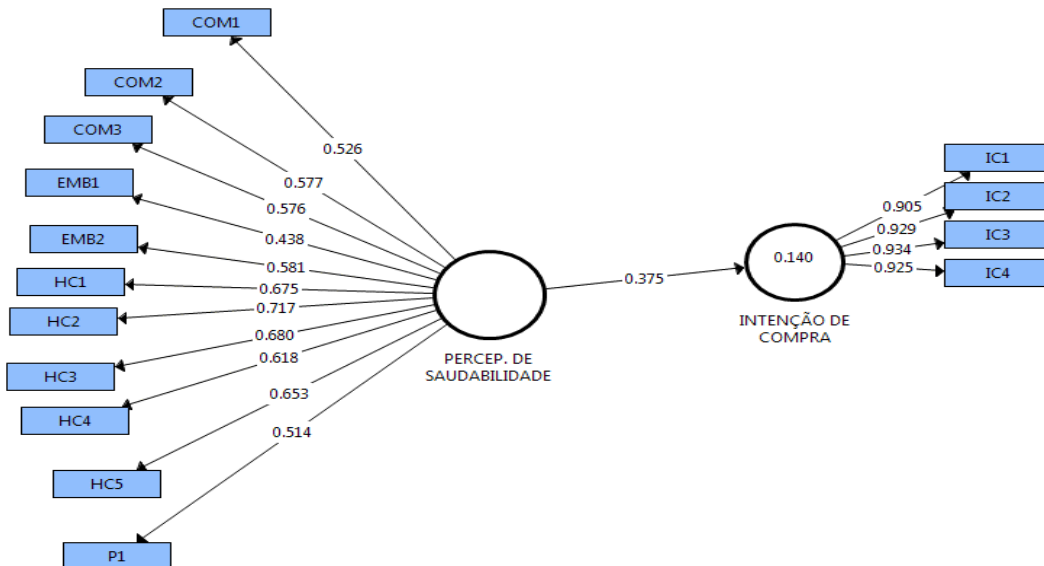


Figura 1- Modelo de mensuração Completo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para admitir que o modelo converge a um resultado satisfatório, os valores das AVEs precisam ser maiores que 0,50. ($AVE > 0,50$). A princípio, a análise da Tabela 3 mostra que apenas o construto Intenção de Compra apresenta $AVE > 0,5$. Assim, fez-se necessário eliminar algumas variáveis observadas do modelo, aquelas de menor carga fatorial, uma vez que a AVE é a média das correlações (cargas fatoriais) elevada ao quadrado.

Tabela 3 - Valores da qualidade de ajuste do modelo MEE inicial

CONSTRUTO	(AVE)	Alfa de Cronbach	R Square	Confiabilidade Composta (CC)
PERCEP. DE SAUDABILIDADE	0.36	0.83	--	0.86
INTENÇÃO DE COMPRA	0.85	0.94	0.14	0.96

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 4 - Valores da qualidade de ajuste do modelo MEE após eliminação das VO

CONSTRUTO	(AVE)	Alfa de Cronbach	R Square	Confiabilidade Composta (CC)
PERCEP. DE SAUDABILIDADE	0.54	0.79	0.151	0.85
INTENÇÃO DE COMPRA	0.85	0.94	--	0.96

Fonte: Elaborado pelos autores

Após remover as variáveis observáveis de menor correlação com o construto, tem-se então $AVE > 0,5$ para ambas variáveis latentes. Garantido a validade convergente, faz-se uma observação dos valores da consistência interna, Alfa de Cronbach (AC) e Confiabilidade Composta (CC), em ambos os casos os resultados são utilizados para entender se a amostra está livre de vieses e se suas respostas são confiáveis. Como parâmetro, a literatura diz que valores do AC acima de 0,60 e 0,70 são considerados adequados para pesquisas exploratórias

enquanto valores entre 0,70 e 0,90 são satisfatórios para CC (HAIR et al., 2014). Como é possível ver na tabela 8, ambos são satisfatórios.

Por fim, para a terceira etapa faz-se se uma avaliação da validade discriminante (VD) do modelo, que mensura se os constructos são independentes entre si. (HAIR et al., 2014). A Tabela 5 apresenta o resultado da validade discriminante com o método de Fornell e Lacker (1981).

Tabela 5 - Validade discriminantes dos construtos utilizando Fornell e Lacker (1981)

	INTENÇÃO DE COMPRA	PERCEP. DE SAUDABILIDADE
INTENÇÃO DE COMPRA	0.92	
PERCEP. DE SAUDABILIDADE	0.39	0.73

Fonte: Elaborado pelos autores

Para análise, se o primeiro número (que é a raiz quadrada da AVE e está identificado na tabela acima em tom de cinza mais escuro) de qualquer coluna for maior que os números abaixo (correlações), então há validade discriminante. Logo, testa-se positivo o modelo proposto no trabalho, comprovando-se que eles mensuram diferentes aspectos do fenômeno de interesse.

Tabela 6 - Avaliação da validade discriminante pelo método de Fatores Cruzados

ITEM	PERCEP. DE SAUDAB.	INTENÇÃO DE COMPRA
HC1	0.75	0.25
HC2	0.80	0.28
HC3	0.75	0.37
HC4	0.67	0.20
HC5	0.69	0.29
IC1	0.36	0.91
IC2	0.37	0.93
IC3	0.36	0.93
IC4	0.34	0.92

Fonte: Elaborado pelos autores

No entanto, há ainda uma segunda análise para atestar a validade discriminante, essa segunda é conhecida como *Cross-Loading* ou Fatores Cruzados em português. No estudo presente, observou-se que todas as variáveis possuem cargas maiores em suas variáveis latentes em relação aos outros construtos do modelo, atestando a validade discriminante como mostrado na Tabela 6. Após ajuste do modelo de mensuração, obteve-se a Figura 2.

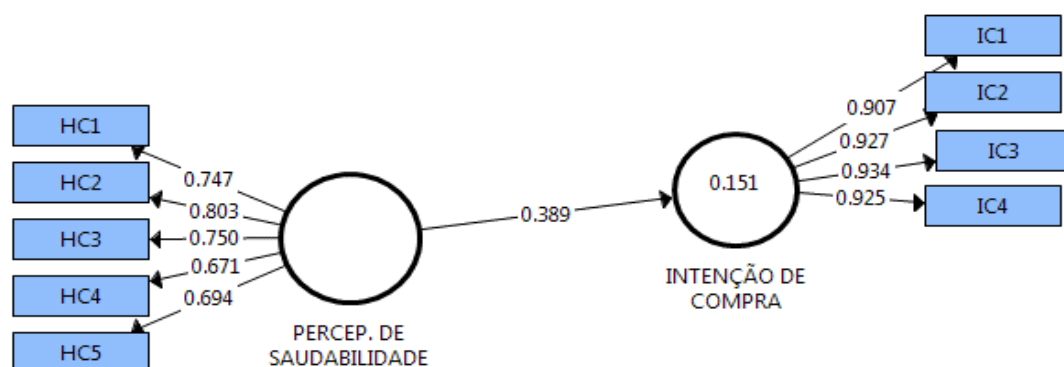


Figura 2 – Modelo ajustado com variáveis significantes

Fonte: Elaborado pelos autores

Em seguida, inicia-se a segunda parte proposta: análise do modelo estrutural. Nessa etapa, desenha-se e testa-se a relação entre as variáveis latentes endógenas e exógenas, conforme estabelecido pela hipótese do estudo. Para essa análise utiliza-se também o procedimento conhecido como bootstrapping. Retomando a hipótese proposta:

H1: Percepção de saudabilidade tem influência significativa na intenção de compra de cervejas mais saudáveis

Inicia-se a análise pelos coeficientes de determinação de Pearson, ou R^2 . Esse coeficiente avalia qual porcentagem da variável endógena pode ser explicada pelo modelo estrutural. No projeto em questão, o R^2 é de 15.1%. Cohen (1988) sugere que acima de 13% o efeito é considerado médio. Como a variável exógena é intenção de compra de uma cerveja, há inúmeros outros fatores que influenciam a compra, assim, 15,1% torna-se importante e aceitável. Na sequência, é necessário avaliar se as relações são significantes ($p \leq 0,05$). Se $p > 0,05$, aceitar-se-ia a hipótese nula e seria necessário repensar as variáveis observáveis/itens do modelo. Ao rodar o Bootstrapping, observou-se que todas as variáveis apresentaram valores para o test t acima de 1,96, valor de referência e os valores de p iguais a zero, comprovando que as relações são significantes estatisticamente.

Por fim, para avaliar a capacidade de predição do modelo, tomou-se outro indicador: Indicador de Stone-Geisser, ou Q^2 , obtido através do módulo Blindfolding no software SmartPLS. Esse indicador avalia a acurácia do modelo ajustado, ou seja, se foi capaz de prever adequadamente o construto endógeno, conforme Hair et al. (2014). Aceita-se o modelo quando $Q^2 > 0$. No estudo em questão, o valor do indicador foi de 0,13 e foi adotado um d de oito (8). Por fim, como última análise de qualidade do ajuste do modelo, analisou-se o Tamanho do efeito (f^2) que demonstra o quanto cada variável latente é útil para o modelo. No presente trabalho, o valor desse indicador foi de 0,18 o que para literatura é entendido com “grande”. Assim, concluímos que o modelo tem acurácia e que os constructos são importantes para um ajuste geral do modelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de responder à pergunta de pesquisa: como a percepção de saudabilidade afeta a intenção de compra de cervejas mais saudáveis, bem como entender quais variáveis tem maior apelo para tal percepção, o presente estudo traz algumas respostas iniciais. Em primeiro lugar, observa-se que atributos como embalagem, preço e comunicação pouco afetam a percepção de saudabilidade de uma cerveja, uma vez que suas cargas fatoriais, ou correlação com o construto, foi pequena e insignificante. Assim, o modelo foi dominado pelos *nutritional claims* que se tornaram as variáveis mais relevantes para a percepção de saudabilidade, em linha com o apresentado no referencial teórico sobre tais.

Entre os *nutritional claims*, observa-se que os que mais tiveram relevância para o modelo foram: *low-carb* em primeiro lugar, orgânica em segundo e *low-calorie* em terceiro. Tais resultados vão de encontro ao comentado no grupo de foco no qual os participantes disseram que os *claims* que seriam mais relevantes eram *low-calorie* e *low-carb* e mostraram-se entusiasmados com a possibilidade de uma cerveja orgânica. Observa-se também que o argumento “*light*” não é tão significante quanto os demais para o modelo. Ainda na etapa qualitativa, levantou-se a hipótese de que uma cerveja “*light*” estaria mais associada a um falso marketing do que a uma cerveja de fato mais saudável, o que vai contra os movimentos realizados nos países desenvolvidos, que possuem em seu portfólio diversas cervejas com o argumento “*light*” dentro do segmento de *Health and Wellness* e também ao apresentado no referencial teórico por Williams (2005). Por fim, observando-se o argumento “*gluten-free*” conclui-se que sua relevância é menor para tal percepção de uma cerveja. Uma possível

explicação é que os consumidores ainda estão confusos com o conceito de “gluten” e/ou não entendem como a ingestão em menor quantidade agregaria para sua saúde.

Ao analisar o impacto da percepção de saudabilidade da cerveja na intenção de compra, obteve-se um resultado considerado por Cohen (1998) como moderado, $R^2 = 15.1\%$, ou seja, 15,1% das variações do construto endógeno (intenção de compra) pode ser explicado pela percepção de saudabilidade, logo, aceita-se a hipótese proposta inicialmente de que tal percepção de uma cerveja tem influência significativa na intenção de compra do consumidor. Tendo em vista que inúmeros outros construtos podem ser considerados para influenciar a compra de uma cerveja mais saudável, acredita-se que 15,1% seja relevante.

Tal resposta pode ser explicada sob a luz da teoria de Banterle et al (2013), que mencionam que *nutritional claims* são uma importante ferramenta para ajudar os consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis e por Missagia e Rezende (2011) que propõem que informações e o marketing de produtos saudáveis tem influência para adoção e manutenção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Assim, de acordo com a pesquisa, a intenção de compra de cervejas mais saudáveis é influenciada pela sua percepção de saudabilidade e de forma mais específica, pelos claims nutricionais. Dessa forma, sugere-se para o varejo explorar cervejas *low-carbs*, *low-calories* ou então, orgânicas, e principalmente a comunicação de tais atributos em seus rótulos, uma vez que a mensagem é valorizada por tais consumidores.

O presente estudo é um trabalho para iniciar-se a discussão sobre cervejas saudáveis no Brasil e possui algumas limitações. Em primeiro lugar, a pesquisa foi realizada majoritariamente com moradores do estado de São Paulo. Assim, o estudo pode ser utilizado como um insight inicial, mas não se deve generalizar o resultado. O período analisado também foi curto e sabe-se que saudabilidade é um contexto bastante transitório, especialmente dado a situação de pandemia mundial na qual esta pesquisa foi realizada. Assim, pesquisas futuras podem apresentar resultados diferentes.

Sugere-se para estudos futuros o desenvolvimento de um modelo que proponha explicar quais fatores influenciam a compra de cervejas ou outras bebidas alcoólicas mais saudáveis, diferente deste estudo que entendeu o impacto de apenas uma variável. Um modelo de comportamento do consumidor de bebidas alcoólicas mais saudáveis por exemplo é uma boa sugestão. Faz-se válido explorar inicialmente os fatores motivacionais, influências de grupos de referência, atributos do produto (disponibilidade, percepção de marca, percepção de preço) e fatores individuais.

Por fim, é importante ter em mente que a associação do consumo de bebidas alcoólicas à promoção de saúde pode ser problemática se não houver cautela. A presente pesquisa não visa encontrar maneiras de convencer o consumidor de que cervejas ou outras bebidas alcoólicas são saudáveis por si só, mas sim que quando ingeridas com moderação podem ser benéficas, além de disponibilizar informações iniciais para propiciar o lançamento de tais no mercado brasileiro, oferecendo outras opções aos consumidores que gostam de cerveja mas preocupam-se com seu bem-estar e saúde.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, Darlan. Consumo de Cerveja deve recuar pelo 3 ano seguido em 2017, mas faturamento do setor cresce. **G1**. 03/12/2017. <<https://g1.globo.com/economia/noticia/consumo-de-cerveja-deve-recuar-pelo-3-ano-seguido-em-2017-mas-faturamento-do-setor-cresce.ghtml>>. Acesso em: 18 mai 2020.
- BANTERLE, A.; CAVALIERE, A.; RICCI, E.C. Food labelled information: An empirical analysis of consumer preferences. **International Journal on Food System Dynamics**, v. 3, n. 2, p. 156-170, 2013.
- BARBOSA, Livia; MADI, Luis; TOLEDO, Maria Aparecida; REGO, Raul. Brazil Food Trends 2020. **São Paulo: ITAL/FIESP**, 2010. 173 p. Disponível em: <

- http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_Food_Trends/files/publication.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2020.
- CARELS, R. A., Harper, J., & Konrad, K. (2006). Qualitative perceptions and caloric estimations of healthy and unhealthy foods by behavioral weight loss participants. **Appetite**, 46, 199–206.
- COHEN, J. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2nd ed. New York: Psychology Press, 1988.
- FALK, L. W.; SOBAL, J.; BISOGNI, C. A.; CONNORS, M.; DEVINE, C. M. Managing healthy eating: definitions, classifications, and strategies. **Health Education & Behavior**. v.28, n.4, p.425-439, ago. 2001
- FORNELL, C., LARCKER, D. F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. **Journal of Marketing Research**, Chicago, n. 18, p. 39-50, Feb. 1981.
- GLOBAL WELLNESS INSTITUTE. **Global Wellness Economy Monitor**. Disponível em: <https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/2018-global-wellness-economy-monitor/>. Acesso em: 05 Mai. 2020.
- GRUNNERT, KG (2005) Food quality and safety: Consumer perception and demand. **Eur Rev Agric Econ** 32, 369–391.
- HAIR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. **Análise multivariada de dados**. Porto Alegre: Bookmam, 2009.
- HAIR, J. F.; SARSTEDT, M.; RINGLE, C. M.; MENA, J. A. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. **Journal of the Academy of Marketing Science**, Thousand Oaks, Forthcoming, 2012.
- HENSELER, J.; RINGLE, C., M.; SINKOVICS, R. R. The use of Partial Least Squares Path Modeling in international marketing. **Advances in International Marketing**, West Yorkshire, v. 20, p. 277-319, 2009
- KENNEDY, E. T. The global face of nutrition: What can governments and industry do? **The Journal of Nutrition**. v.135, p. 913-915, 2005.
- MINTEL. **Mintel's 2030 Global Food and Drink Trends**. Disponível em < <https://www.mintel.com/global-food-and-drink-trends>>. Acesso em: 05 Mai. 2020
- MISSAGIA, S. V.; REZENDE, D. C. A alimentação saudável sob a ótica do consumidor: identificando segmentos de mercado. XXXV **Encontro da ANPAD**. 2011.
- NERMOE, Katie. Millennials, wellness generation. **Sanford Health**. 12/09/2018. Disponível em: <https://news.sanfordhealth.org/sanford-health-plan/millennials-wellness-generation>. Acesso em: 12 out. 2019.
- PAQUETTE, M. C. Perceptions of healthy eating: State of knowledge and research gaps. **Canadian Journal of Public Health**. v.96, suplemento 3, jul./ago. 2005
- ROBERTO, C.A., BRAGG, M.A., SCHWARTZ, M.B., SWAMANS, M.J., MUSICUS, A., Novak, N. e Brownell, K.D. Facts up front versus traffic light food labels: a randomized controlled trial. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 43, n.2, pp.134-141, 2012.
- SHEMILT, I.; HENDRY, V.; MARTEAU, T. M. What do we know about the effects of exposure to “Low Alcohol” and equivalent product labelling on the amounts of alcohol, food, and tobacco people select and consume? A systematic review. **BMC Public Health**, v. 29, n. 17, 2017
- VENDEMIATTI, Alexandre. Beer Marketing Report. USDA - **United States Department of Agriculture**. 13/02/2020. Disponível em: <http://usdabrazil.org.br/pt-br/reports/beer-market-report-2019.pdf>. Acesso em: 15 maio 2020.
- WILLIAMS, Peter. “Consumer understanding and use of health claims for foods.” **Nutrition Reviews**, v (63), n.7, 2005, p. 256-64.
- WRIGHT, C.A. & Bruhn, Christine & Heymann, H & Bamforth, Charles. (2008). Beer and Wine Consumers' Perceptions of the Nutritional Value of Alcoholic and Nonalcoholic Beverages.

Journal of Food Science. 73. 2007.

ZEGLER, Jennifer. Better-for-you beer has room to grow in Brazil. **Mintel Blog.** 06/02/2020.
<<https://www.mintel.com/blog/drink-market-news/better-for-you-beer-has-room-to-grow-in-brazil>> Acesso em: 20 abr. 20